

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Fallos de Memoria de la Vida Cotidiana (Memory Failures of Everyday) (MFE)

Eje V • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	MFE
Nombre completo	Cuestionario de Fallos de Memoria de la Vida Cotidiana (Memory Failures of Everyday)
Versión / edición	Versión de 28 ítems (Sunderland, Harris & Gleave, 1984), la más utilizada; existe una versión previa de 35 ítems (Sunderland, Harris & Baddeley, 1983). Adaptación española de García-Martínez y Sánchez-Cánovas (1993).
Idioma	Español (España).
Autores (original)	Sunderland, A., Harris, J. E., & Gleave, S. (versión de 28 ítems, 1984); versión previa Sunderland, Harris & Baddeley (1983). Adaptación española: García-Martínez, M., & Sánchez-Cánovas, J.
Año (original / adaptación)	1983/1984 (original); 1993 (adaptación española).

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	Eje V — Funcionamiento cognitivo y neuropsicológico
Etiquetas	Memoria cotidiana; metamemoria; quejas subjetivas de memoria; autoinforme.
Pregunta clínica que responde	¿Hay variables cognitivas para explorar o derivar?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: Fallos de memoria autopercebidos en la vida cotidiana (metamemoria): olvidos al hablar/leer/escribir, nombres y caras, acciones y aprendizaje de cosas nuevas.

Finalidad: Evaluación subjetiva de la memoria cotidiana; valorar la situación actual del paciente y su evolución en el tiempo o a causa de un tratamiento (rehabilitación, entrenamiento de memoria).

Usos apropiados:

- Cribado de quejas subjetivas de memoria en adultos y personas mayores.
- Seguimiento de cambios subjetivos en memoria cotidiana tras rehabilitación neuropsicológica o entrenamiento de memoria.
- Investigación sobre memoria cotidiana en daño cerebral traumático, demencia, esclerosis múltiple, epilepsia y envejecimiento normal/patológico.
- Complemento a pruebas objetivas de memoria (p. ej. listas de palabras, escenas de escalas de memoria tipo Wechsler) dentro de una evaluación multimétodo.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico aislado de deterioro cognitivo o demencia.
- Sustituto de pruebas objetivas de memoria.
- Uso como única fuente en presencia de anosognosia relevante (las quejas subjetivas pueden no correlacionar con el rendimiento objetivo, especialmente en cuadros demenciales avanzados).

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos jóvenes y personas mayores; usado también en daño cerebral traumático, demencia, esclerosis múltiple y epilepsia. Estudio de factores con población española: 647 adultos de 19 a 64 años (Montejo, Montenegro, Sueiro-Abad & Huertas, 2014).
Contexto de aplicación	Clínico (neuropsicología, rehabilitación, geriatría), investigación.
Informante	Autoinforme; también puede ser respondido por un familiar/allegado en algunos estudios (en cuyo caso deja de valorar metamemoria propiamente dicha).
Modalidad de administración	Papel y lápiz; individual o colectivo.

5. Estructura y administración

Número de ítems	28 ítems (versión más utilizada,
------------------------	----------------------------------

	Sunderland et al., 1984), agrupados en 4 categorías de contenido: hablar/leer/escribir, nombres y caras, acciones, y aprender cosas nuevas.
Periodo temporal de referencia	Últimos seis meses (confirmado en el Protocolo.pdf de este acervo: "le ha ocurrido cada una de ellas en los últimos seis meses"). CORREGIDO 2026-08-10: no son 3 meses como se reportó inicialmente a partir de la versión original de Sunderland et al. citada en fuentes secundarias.
Formato de respuesta	Escala Likert de 3 puntos (confirmado en Protocolo.pdf): 0 = Nunca o rara vez, 1 = Algunas veces, 2 = Muchas veces. CORREGIDO 2026-08-10: no son 9 opciones; el protocolo local usa la versión reducida de 3 puntos, no la escala original de 9 opciones de Sunderland et al. (1984).
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 5-10 minutos).

6. Dimensiones y puntuaciones

La estructura factorial varía según el estudio. En población española (Montejo, Montenegro, Sueiro-Abad & Huertas, 2014; Anales de Psicología, 30(1), muestra N=647 adultos 19-64 años), se identificó una estructura de 3 factores que explicaban el 29.3% de la varianza: Recuerdo de Actividades, Monitorización de la Comunicación y Reconocimiento. Sunderland et al. (1984) originalmente reportaron un factor general subyacente (39%-60% de la varianza según muestra). Otros estudios internacionales (Richardson 1996, Cornish 2000, Efklides et al. 2002, Royle & Lincoln 2008) reportan entre 3 y 7 factores distintos, reflejando inestabilidad factorial entre poblaciones y metodologías.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de las puntuaciones de los 28 ítems (0-2 por ítem) y/o por factor/categoría; a mayor puntuación, mayor frecuencia de fallos de memoria percibidos, según la escala 0-2 confirmada en el Protocolo.pdf de este acervo.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes consultadas.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.

Rango posible	Rango posible 0-56 (28 ítems × 2, escala 0-2 confirmada en el protocolo local). No se localizaron rangos por factor publicados — no verificado.
Puntos de corte	No se localizaron puntos de corte clínicos de consenso — no verificado, no usar para decisiones diagnósticas.

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

García-Martínez, M. y Sánchez-Cánovas, J. (1993) realizaron la adaptación española. Montejo, P., Montenegro, M., Sueiro-Abad, M. J., & Huertas, E. (2014). Cuestionario de Fallos de Memoria de la Vida Cotidiana (MFE): análisis de factores con población española. *Anales de Psicología*, 30(1), 320-328. DOI: 10.6018/analesps.30.1.131401. Muestra: 647 adultos jóvenes (19-64 años), España (Madrid, estudio realizado en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo, Madrid Salud, y la Universidad Complutense de Madrid). Estructura de 3 factores (Recuerdo de Actividades, Monitorización de la Comunicación, Reconocimiento) que explican el 29.3% de la varianza; los dos primeros factores se asociaron más con el estado de ánimo y las quejas generales de memoria, mientras que Reconocimiento se asoció con la edad y negativamente con el rendimiento objetivo de memoria (evaluado con Listas de Palabras y Escenas de la Escala de Memoria de Wechsler-III, y con la Escala de Depresión y Ansiedad de Goldberg).

9. Adaptación cultural y norma local

Adaptación española de García-Martínez y Sánchez-Cánovas (1993), con estudio adicional de estructura factorial en población española (Montejo et al., 2014). No se localizaron normas poblacionales de corte estandarizadas para España o Latinoamérica en la búsqueda realizada — no verificado.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- Es un autoinforme de metamemoria; puede no correlacionar bien con el rendimiento objetivo de memoria, especialmente en cuadros con anosognosia (p. ej. demencias más avanzadas).
- No sustituye pruebas objetivas de memoria ni la evaluación neuropsicológica formal.
- La estructura factorial es inestable entre estudios y poblaciones; interpretar las subescalas con cautela y preferir la puntuación total o replicar el análisis factorial en la población de uso.

- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Ante sospecha de deterioro cognitivo relevante, derivar a evaluación neuropsicológica objetiva (p. ej. MMSE, MoCA, TAVEC, Figura de Rey, ya presentes en este acervo).

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El MFE es un cuestionario ampliamente reproducido en la literatura científica de acceso académico (capítulos de libro, artículos científicos) desde su publicación original en 1983/1984. La adaptación española y los estudios de estructura factorial se han publicado en revistas científicas (Anales de Psicología, acceso abierto vía SciELO). El Protocolo.pdf de este acervo es un escaneo de un documento de circulación académica/clínica (ya presente en el acervo local del proyecto), identificado por OCR y contrastado con las fuentes citadas. No se identificó una licencia comercial restrictiva vigente en la búsqueda realizada, pero se recomienda verificar condiciones de reproducción con los titulares/editoriales antes de cualquier uso comercial o redistribución masiva — no verificado con certeza absoluta.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Sunderland, A., Harris, J. E., & Baddeley, A. D. (1983). Do laboratory tests predict everyday memory? A neuropsychological study. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 22, 341-357.

Sunderland, A., Harris, J. E., & Gleave, J. (1984). Memory failures in everyday memory following severe head injury. *Journal of Clinical Neuropsychology*, 6, 127-142.

García-Martínez, M., & Sánchez-Cánovas, J. (1993/1994). Adaptación española del Cuestionario de Fallos de Memoria de la Vida Cotidiana (MFE).

Montejo, P., Montenegro, M., Sueiro-Abad, M. J., & Huertas, E. (2014). Cuestionario de Fallos de Memoria de la Vida Cotidiana (MFE): análisis de factores con población española. *Anales de Psicología*, 30(1), 320-328. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282014000100034 <https://doi.org/10.6018/analesps.30.1.131401>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (escaneo local del acervo del proyecto, 1 página, legible;
----------------------------	--

	identidad verificada por OCR + comparación con fuentes web citadas). Ficha Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Ficha documental generada a partir de fuentes primarias y secundarias verificables (incluye lectura de artículo original en Anales de Psicología); requiere revisión humana antes de uso clínico formal. Protocolo local abre correctamente y contiene el cuestionario completo (verificado con pypdf).

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0